

Historia clínica

1. *Antecedentes familiares* de deformidades de la columna o patología espinal.
2. *Edad*.
3. *Estadio de madurez sexual de Tanner y edad de la menarca*.
4. *Dolor*: La mayoría de las escoliosis en el adolescente son asintomáticas. Sin embargo, el 25% de los pacientes tiene dolor de espalda en la presentación inicial y otro 9% lo desarrolla durante el seguimiento. Ante la presencia de dolor constante, nocturno o radicular, es necesario excluir una patología subyacente.^{9,10}
5. *Síntomas neurológicos*: Disfunción vesical o anal, retraso madurativo motor o intelectual.
6. *Antecedentes de enfermedades o traumatismos previos*.

Examen físico

1. *Talla*: La determinación seriada de la talla ayuda a determinar el pico de empuje puberal (PEP), que constituye un buen factor de predicción relacionado con el grado de progresión de la curva. Para calcular el PEP, es necesario disponer de tallas en intervalos regulares de 6 meses, al menos, en tres oportunidades. En las niñas, este valor es de 9 cm/año y ocurre, en promedio, a los 12 años de edad cronológica y, en los varones, es de 10 cm/año y ocurre, en promedio, a los 14 años.
2. *Etapas de madurez sexual* (estadios de Tanner), disponibles en http://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/libro_verde_sap_2013.
3. *Piel y sistema músculo-esquelético*: Manchas café con leche, nódulos subcutáneos y pecas axilares (neurofibromatosis de Von

Recklinghausen), parches pilosos lumbares u hoyuelos en la piel lumbosacra (disrafismos) e hiperelasticidad (Marfan, Ehlers-Danlos).

4. *Asimetría pelviana*: Discrepancia de MM. II. (pseudoescoliosis).
5. *Examen neurológico*: La existencia de pies cavos, la debilidad en miembros superiores y/o inferiores, la asimetría o ausencia de los reflejos cutáneo-abdominales o la presencia de hiperreflexia rotuliana y/o aquileana deberían originar la sospecha del origen "no idiopático" de la escoliosis.

Examen de la columna

El paciente debe estar de pie, descalzo, con las piernas extendidas y la espalda descubierta y accesible al examinador con su postura habitual y sin correcciones.

Con el paciente de espalda, se debe observar lo siguiente (*Figura 1*):

- Nivel de los hombros.
- Nivel de las escápulas.
- Nivel de la pelvis.
- Centrado del tronco o *signo de la plomada* (debe coincidir entre la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y la línea interglútea).
- Simetría del *triángulo de la talla* (relación entre el borde interno de los miembros superiores y del contorno del tronco).
- *Maniobra de Adams*: Se le solicita al paciente que se incline hacia adelante, con la cabeza lo más descendida posible sin flexionar las rodillas hasta que los hombros queden a la altura de las caderas mientras mantiene los brazos extendidos y péndulos y las palmas juntas (a modo de rezo).⁹⁻¹¹

TABLA 1. Escoliosis secundaria

Escoliosis congénita	• Vertebral: mielomeningocele, hemivértebras, vértebras en cuña, barras vertebrales • Extravertebral: fusiones congénitas de las costillas
Escoliosis neuromuscular	• Formas neuropáticas: enfermedad de la motoneurona inferior (poliomielitis, mielomeningocele, trauma), enfermedad de la neurona motora superior (parálisis cerebral, traumatismos, tumores espinales, siringomielia) • Formas miopáticas: progresiva (distrofia muscular), estática (artrogriposis)
Escoliosis sindrómica	• Síndromes mesenquimales: síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos • Desórdenes metabólicos: osteogénesis imperfecta, raquitismo • Neurofibromatosis • Osteocondrodistrofias: enanismo acondroplásico, enanismo diastrófico, mucopolisacaridosis, displasia espondiloepifisaria
Otras causas	• Enfermedad reumatoidea • Traumática (fractura, posirradiación, cirugía) • Tumores óseos (osteoma osteoide, histiocitosis X)

Tabla 1. Causas de escoliosis secundaria.²

De esta manera, se evaluará la presencia de giba/s, expresión clínica de la rotación vertebral. La maniobra es positiva cuando la giba está presente (Adams positivo) y negativa cuando está ausente (Adams negativo). La maniobra detecta la rotación vertebral, pero no la cuantifica (Figura 2).

En una curva no estructurada (actitud escoliótica), no se evidencia giba (Adams negativo).

Medición del ángulo de rotación del tronco/ángulo de inclinación del tronco con escoliómetro:

El escoliómetro es un instrumento que se coloca en la espalda durante la maniobra de Adams y puede ser usado para brindar una medida objetiva de la rotación de la curvatura, pero su uso no es necesario para hacer el diagnóstico de escoliosis en atención primaria.⁸

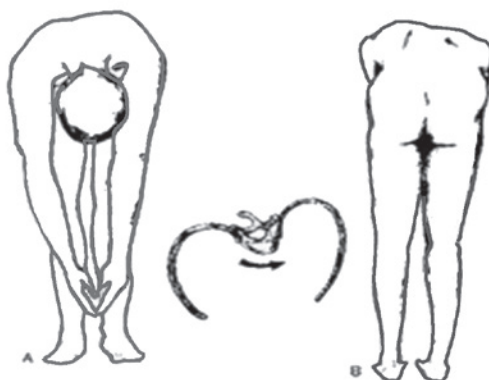
La rotación de 5° se extrapola (a 20°) (Cobb)^{2,10} (Figura 3).

- *Maniobra de Adams sentado:* Se utiliza para eliminar la oblicuidad de la pelvis en caso de asimetría de MM. II. Su especificidad aumenta porque elimina las asimetrías discretas debidas a discrepancia de longitud de MM. II., alteraciones de la cadera o distorsión pélvica.¹²

Con el paciente de perfil, se debe observar lo siguiente:

- Antepulsión de hombros.
- Abdomen prominente por falta de tono muscular abdominal.

FIGURA 2. Maniobra de Adams



Maniobra de Adams: paciente inclinado hacia adelante, con la cabeza lo más descendida posible (mirando al piso) sin flexionar las rodillas hasta que los hombros queden a la altura de las caderas mientras mantiene los brazos pendlulos y las palmas juntas (a modo de rezo). Se debe observar la asimetría de los hemidorsos, con la presencia de giba/s. La maniobra es positiva cuando la giba está presente (Adams positivo) y negativa cuando está ausente (Adams negativo).

FIGURA 1. Evaluación del paciente



Examen físico del paciente portador de escoliosis. Aspectos clínicos en los planos frontal (la línea de la plomada –virtual desde C7– señala el tronco descentrado a la derecha), sagital y axial con la presencia de dos gibas importantes (torácica derecha y lumbar izquierda) con la paciente en inclinación hacia adelante (maniobra de Adams). (Cedida por el Dr. Maenza)